Tutoria UC14 · Resumo para a prova final

roxo = caiu (provas/APFs) · amarelo = dica dos tutores · ✎ = pegadinha · ✗ = erro na APF

SP1 · ABDOME AGUDO

AS 5 SÍNDROMES E O EXAME INICIAL

5 síndromes → exame INICIAL → conduta

Inflamatório	dor que piora e localiza, febre	**USG (biliar/pelve) · TC**	apendicite, colecistite, diverticulite, pancreatite (clínica)
Perfurativo	dor súbita, difusa, tábua, Jobert	**RX 3 incidências (ar livre)**	laparotomia/laparoscopia de urgência
Obstrutivo	cólica, distensão, vômitos, parada de gases	**RX abdome em pé + deitado → TC**	jejum + SNG + hidratação; cirurgia se sofrimento
Vascular	dor súbita desproporcional, FA, lactato ↑	**ANGIO-TC**	heparina + revascularização
Hemorrágico	dor + choque; mulher fértil	**β-HCG + USG (FAST)**	cirurgia (ectópica rota, AAA)

- Abdome agudo = dor abdominal de início recente (horas a poucos dias) que exige decisão rápida, clínica ou cirúrgica. O raciocínio que ela cobra é sempre o mesmo: **síndrome → exame inicial → conduta**.
- "Exame INICIAL" = rotina de abdome agudo: RX de tórax PA em ortostase + abdome em pé + abdome deitado (as "3 incidências"). TC é o mais sensível, mas não é o inicial. Isquemia → angio-TC · vesícula → USG · mulher fértil → β-HCG + USG transvaginal · diverticulite → TC com contraste.

✎ *T11 Q4: AINE + dor súbita + abdome tenso = perfuração → exame inicial =* RX em 3 incidências *(a TC era o distrator) · T9 Q2: obstrução →* RX de abdome *· T11 Q2: idoso distendido →* radiografias abdominais*.*

✎ *APF T12: obstrutivo =* cólica + parada de gases e fezes *(✗Murphy, ✗intussuscepção, ✗cirurgia na maioria) · perfurativo =* pneumoperitônio no RX em ortostase é frequente *(✗"tratamento clínico na maioria").*

✎ *T11 Q3: pancreatite =* abdome agudo CLÍNICO *(inflamatório de tratamento clínico) que pode evoluir com complicações sistêmicas — não é cirúrgico desde o início.*

O que procurar no raio X do abdome agudo



Ar sob as cúpulas
pneumoperitônio → PERFURAÇÃO



Níveis hidroaéreos em escada
distensão de delgado → OBSTRUÇÃO



"Grão de café" / U invertido
alça sigmoide gigante → VOLVO

Rotina de abdome agudo = tórax PA em pé + abdome em pé + abdome deitado (as "3 incidências")

Onde dói → o que pensar

roxo = região que já caiu em prova (T9–T11 / APF)

Hipocôndrio D Colecistite · cólica biliar Colangite · hepatite Abscesso hepático	**Epigástrio** Úlcera (perfurada) · DRGE Pancreatite (em faixa) IAM inferior!	**Hipocôndrio E** Baço (infarto/ruptura) Pancreatite (cauda)
Flanco D Cólica renal · pielonefrite Cólon ascendente	**Mesogástrio** Apendicite INICIAL Isquemia mesentérica Obstrução de delgado	**Flanco E** Cólica renal Cólon descendente
Fossa ilíaca D Apendicite (McBurney) Ectópica · anexos Crohn ileal	**Hipogástrio** Cistite · retenção DIP · útero	**Fossa ilíaca E** Diverticulite Volvo de sigmoide Ectópica · anexos

Dor difusa + abdome em tábua = peritonite (perfurativo) · dor desproporcional ao exame = vascular

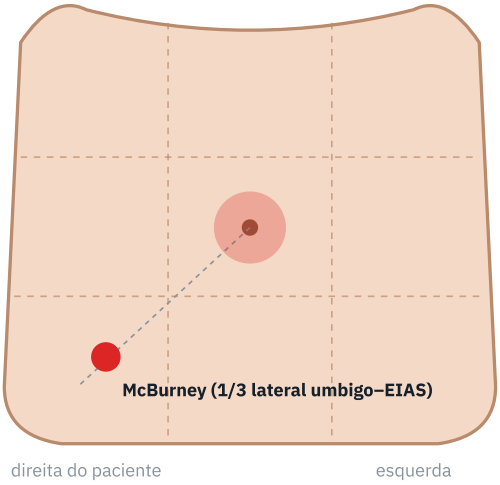
- Dor visceral (mal localizada, linha média, cólica) → parietal (localizada, contínua, piora ao mover) = inflamação chegando ao peritônio. Na apendicite: **periumbilical → FID**.
- **Blumberg** (descompressão dolorosa no ponto de McBurney) · **Rovsing** (palpar FIE dói na FID) · psoas/obturador (apêndice retrocecal/pélvico) · **Murphy** (parada da inspiração à palpação do HD = colecistite) · **Giordano** (punho-percussão lombar = rim) · Cullen/Grey-Turner (equimose periumbilical/flancos = pancreatite hemorrágica).
- Sinal de Jobert: timpanismo no hipocôndrio direito, onde deveria haver macicez hepática = pneumoperitônio → úlcera perfurada.
- Peritonite: paciente imóvel, abdome em tábua, RHA abolidos. Obstrução: distensão, RHA **aumentados, metálicos, "em rajadas"** (fase inicial) → silêncio (fase tardia).
- Idoso: dor e febre menos intensas, exame pobre — subestima a gravidade; dor desproporcional ao exame = pensar em vascular.

✎ *T9 Q1 e APF: timpanismo em HD + ausência de macicez hepática =* úlcera perfurada com pneumoperitônio.

INFLAMATÓRIO: APENDICITE · DIVERTICULITE

Apendicite: a dor migra

visceral (mal localizada, periumbilical) → parietal (fixa na fossa ilíaca direita)



1º · dor periumbilical, mal definida
visceral; anorexia, depois náusea/vômito

2º · migra para a fossa ilíaca direita
parietal: contínua, piora ao mover; febre baixa

Exame: Blumberg, Rovsing, psoas, obturador
Alvarado ≥ 7 = alta probabilidade → cirurgia

Apendicectomia VLP + ATB (cefazolina ou ceftriaxona + metronidazol)

- Apendicite: dor periumbilical que migra para FID, anorexia, náusea/vômito depois da dor, febre baixa, Blumberg. Diagnóstico **clínico** (Alvarado ≥ 7); imagem se dúvida (USG em criança/gestante, TC no adulto). Conduta: **apendicectomia** (VLP) + ATB (cefazolina ou ceftriaxona + metronidazol).
- Diverticulite = "apendicite da esquerda": idoso, constipação crônica, dor em FIE + febre. Exame: **TC com contraste** (Hinchey). Não complicada: dieta líquida, analgesia, ATB VO (amoxi-clav ou cipro + metronidazol 7–10 d; pode dispensar ATB em imunocompetente selecionado). Abscesso > 3–4 cm: drenagem percutânea. Peritonite purulenta/fecal (Hinchey III–IV): cirurgia (Hartmann). **Colonoscopia só após 6–8 semanas** (nunca na fase aguda).

✎ *T11 Q1: 64 a, constipada, dor em QIE + febre →* diverticulite colônica aguda · *T10 Q3: periumbilical → FID + Blumberg →* apendicite.

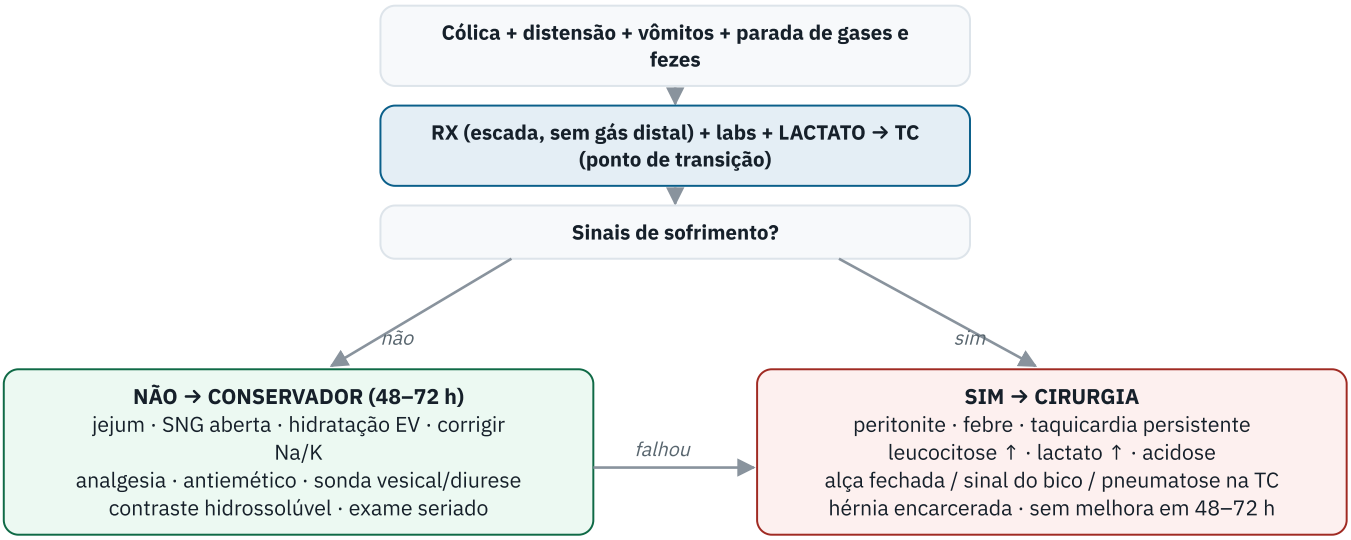
✎ *APF T12 discursiva:* "preencha a primeira prescrição" do paciente com apendicite → dieta zero · SF/Ringer EV · dipirona 1 g EV 6/6 h (± morfina) · ondansetrona 4 mg EV 8/8 h · ATB (cefazolina 2 g na indução; complicada: ceftriaxona 2 g/d + metronidazol 500 mg 8/8 h) · sinais vitais/diurese · exames (hemograma, PCR, EAS, β-HCG) · apendicectomia VLP. *Ordem: dieta → hidratação → analgesia → antiemético → ATB → cuidados → exames → procedimento.*

PERFURATIVO

- Dor **súbita, lancinante**, epigástrica que vira difusa, abdome em tábua, Jobert. Causa principal: úlcera péptica perfurada (AINE, H. pylori, tabaco).
- RX: **pneumoperitônio** (ar sob as cúpulas). Conduta: jejum, SNG, hidratação, IBP EV, ATB, **cirurgia de urgência** (rafia + epiploplastia) e depois erradicar H. pylori.

OBSTRUTIVO

Obstrução intestinal: conservador ou cirurgia



Causa nº 1 no delgado = bridas (cirurgia prévia) · cólon do idoso = neoplasia, volvo, fecaloma · volvo sem sofrimento = descompressão endoscópica

- Cólica + distensão + vômitos + **parada de eliminação de gases e fezes**. Delgado alto: vômitos precoces e biliosos, pouca distensão. Cólon: distensão grande, vômitos tardios/fecaloides.
- Causa nº 1 de obstrução de DELGADO = bridas/aderências (cirurgia prévia); depois hérnias. Cólon: **neoplasia** (idoso, emagrecimento, fezes afiladas), **volvo de sigmoide** (idoso institucionalizado, constipado — RX "grão de café"/U invertido), fecaloma.
- RX: níveis hidroaéreos **em escada**, distensão (delgado > 3 cm, cólon > 6 cm, ceco > 9 cm), **ausência de gás distal**. TC: **ponto de transição**, causa, sinais de sofrimento (**sinal do bico**, alça fechada, pneumatose, edema de parede, líquido livre).
- Protocolo inicial (sem sofrimento): jejum + SNG aberta + hidratação EV + correção de Na/K + analgesia + antiemético + sonda vesical/diurese + exame seriado; contraste hidrossolúvel (gastrografina) é diagnóstico e terapêutico.
- Conservador × cirurgia: conservador por 48–72 h se estável, sem peritonite, sem sinais de isquemia. **Falha/operar**: peritonite, febre, taquicardia persistente, leucocitose crescente, **lactato ↑**, acidose, alça fechada/sinal de sofrimento na TC, obstrução completa, sem contraste no cólon em 24 h, sem melhora em 48–72 h, hérnia encarcerada.
- Volvo de sigmoide sem sofrimento: **descompressão por retossigmoidoscopia** + sigmoidectomia eletiva (recidiva alta). Com sofrimento: cirurgia.
- Lactato: marcador de hipoperfusão/isquemia de alça (estrangulamento); normal não exclui.

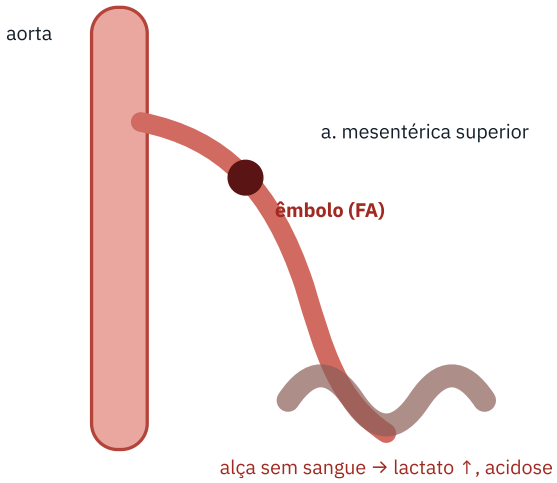
✎ ***Discursiva de obstrução caiu nas 3 turmas**: T9 (idoso constipado, "dessa vez não funcionou"), T10 e T11 (bridas pós-cirurgia). Itens que se repetem: diagnóstico sindrômico + etiologia, exames (lab + RX + TC), utilidade do lactato, conduta das primeiras horas, conservador × falha.*

✎ *Erros que custaram ponto: simeticona "para os gases" como conduta (T10) · "USG mostra fezes impactadas onde há aderências" (T11 — USG não vê bridas) · esquecer SNG e diurese (T9).*

VASCULAR · HEMORRÁGICO

Isquemia mesentérica aguda

dor DESPROPORCIONAL ao exame físico



Quem: idoso, FA/IAM recente, aterosclerose

Dor súbita intensa · abdome flácido · diarreia/sangue
lactato ↑ + acidose metabólica

ANGIOTOMOGRAFIA (exame de escolha)

Ressuscitação + HEPARINA plena + ATB
revascularização (embolectomia/endovascular)
peritonite → laparotomia + ressecção

- Isquemia mesentérica aguda: idoso, FA/IAM recente (êmbolo na AMS), dor súbita intensa DESPROPORCIONAL ao exame (abdome flácido), lactato ↑, acidose, às vezes diarreia/sangue. Exame: angio-TC. Conduta: ressuscitação, heparina plena precoce, ATB, revascularização (embolectomia/endovascular); laparotomia se peritonite (ressecar alça necrótica).
- Hemorrágico: gravidez ectópica rota (atraso menstrual, dor súbita em fossa ilíaca, dor no ombro, choque → β-HCG + USG TV → cirurgia) · AAA roto (idoso, tabagista, dor abdominal/lombar + massa pulsátil + choque → cirurgia sem TC se instável).
- Hemorrágico: choque hipovolêmico rápido; FAST ajuda; NEM SEMPRE há irritação peritoneal (sangue irrita pouco no início) — a incorreta da APF T12.

✎ *T10 Q1–2 = **APF T12 Q4–5 (o mesmo caso, reaproveitado!)**: 72 a, arritmia, dor 9/10 sem peritonite, lactato ↑ → isquemia mesentérica → TC contrastada + anticoagulação (quem marcou "jejum, hidratação, ATB" errou: faltava o essencial) · T9 Q3:* β-HCG + USG transvaginal.

CONSTIPAÇÃO

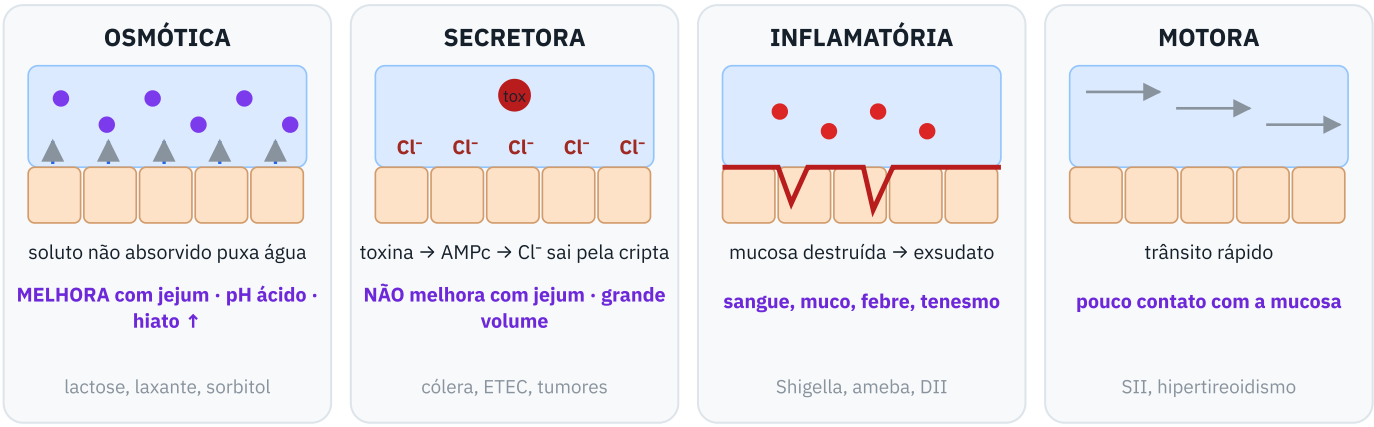
- Roma IV: ≥ 2 de esforço, fezes duras (Bristol 1–2), evacuação incompleta, bloqueio, manobras manuais, < 3 evacuações/semana, em ≥ 25% das evacuações, por 3 meses.
- Alarme (colonoscopia): > 45–50 a, sangue, anemia, emagrecimento, mudança recente do hábito, história familiar de CA colorretal. Tratamento: fibras + água + atividade → laxante osmótico (PEG/lactulose) → estimulante. Criança: desimpactação (PEG) + manutenção + treino de toalete.

SP2 · DIARREIA E PARASITOSES

DEFINIÇÕES E MECANISMOS

- Diarreia = ≥ 3 evacuações amolecidas/líquidas em 24 h. Duração: aguda < 14 dias · persistente 14–29 dias · crônica ≥ 30 dias. Disenteria = sangue/muco.
- > 90% das agudas são infecciosas, transmissão fecal-oral (água/alimento contaminado). Na criança, a maioria é viral (rotavírus, norovírus) e autolimitada em até 7 dias; disenteria = bactéria invasiva (Shigella, Campylobacter, Salmonella, EIEC) — não rotavírus.

Os 4 mecanismos da diarreia



✎ *T11 Q8: Vibrio cholerae → adenilato ciclase → AMPc →* secretora (não regride com jejum) *· T10 Q4: diarreia após leite que melhora ao evitar →* osmótica → teste do H_2 expirado/tolerância à lactose + exclusão *· T9 Q6:* aguda NÃO é 2–4 semanas *· APF T12: 16 dias =* persistente*; osmótica =* cessa com o jejum*.*

AVALIAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO E PLANOS A · B · C

Avaliar a desidratação → escolher o plano (MS)

SEM desidratação → PLANO A (casa)
alerta · olhos normais · bebe normal
SRO após cada evacuação:
< 1 a 50–100 mL · 1–10 a 100–200 mL
> 10 a à vontade · manter dieta
ZINCO 10 mg (< 6 m) / 20 mg 10–14 d
sinais de retorno

COM desidratação → PLANO B (unidade)
≥ 2: irritado, olhos fundos,
BEBE AVIDAMENTE, prega lenta
SRO 50–100 mL/kg em 4–6 h
vomitou? → gastróclise 20–30 mL/kg/h
reavaliar: melhorou → A
piorou → C

GRAVE → PLANO C (EV)
≥ 2: LETÁRGICO, bebe mal/não bebe,
prega > 2 s, TEC > 5 s, pulso fino
SF 0,9% / Ringer — expansão:
< 1 a: 30 mL/kg em 1 h + 70 em 5 h
≥ 1 a: 30 mL/kg em 30 min + 70 em 2h30
SRO 5 mL/kg/h assim que beber

Observar	Sem desidratação	Com desidratação (≥ 2)	Grave (≥ 2, incl. 1 *)
Estado geral	alerta	irritado, intranquilo	* comatoso, hipotônico, **letárgico**
Olhos / lágrimas	normais / presentes	fundos / ausentes	muito fundos / ausentes
Sede	bebe normal	**sedento, bebe avidamente**	* bebe mal ou não consegue
Prega	desaparece rápido	lentamente	muito lenta (> 2 s)
Pulso / TEC	cheio / < 3 s	rápido, fraco / 3–5 s	* muito fraco ou ausente / > 5 s

- Plano A (casa): líquidos + **SRO após cada evacuação: < 1 a 50–100 mL · 1–10 a 100–200 mL · > 10 a à vontade**; manter alimentação; zinco 10 mg/d (< 6 m) ou 20 mg/d (≥ 6 m) por 10–14 dias; ensinar **sinais de retorno** (piora, sangue, vômitos, não bebe, febre, sonolência).
- Plano B (unidade, observado): SRO 50–100 mL/kg em 4–6 h; vomitou? → reduzir/fracionar ou **gastróclise por SNG 20–30 mL/kg/h**; reavaliar → hidratado = A · piorou/letargia = C.
- Plano C (EV) com **SF 0,9% ou Ringer — dois esquemas já caíram** (figura abaixo): cartaz antigo: < 5 anos 20 mL/kg em 30 min, repetir até hidratar (gabarito da APF) · cartaz 2023: < 1 ano 30 mL/kg em 1 h + 70 em 5 h; ≥ 1 ano 30 mL/kg em 30 min + 70 em 2h30 (T10). Reavaliar; SRO 5 mL/kg/h assim que beber; depois manutenção (Holliday-Segar: 100 mL/kg até 10 kg, + 50/kg de 10–20, + 20/kg acima) + reposição.

Plano C (EV): os dois esquemas que já caíram

Cartaz antigo do MS
< 5 anos: SF 0,9% 20 mL/kg em 30 min — repetir até hidratar
> 5 anos: SF 30 mL/kg em 30 min + Ringer 70 mL/kg em 2h30
gabarito da APF T12 (Tutora)

Cartaz MS 2023
< 1 ano: 30 mL/kg em 1 h + 70 mL/kg em 5 h
≥ 1 ano: 30 mL/kg em 30 min + 70 mL/kg em 2h30
gabarito da T10 (Q6)

O que nunca muda: GRAVE = Plano C = EV com SF/Ringer · reavaliar · SRO assim que beber

- SRO de osmolaridade reduzida (OMS): **Na 75 mmol/L, glicose 75 mmol/L, osmolaridade 245** (90/111 = SRO antiga) · 1 envelope em 1 L de água, usar em 24 h · soro caseiro ≠ SRO.
- Antibiótico só em: disenteria com comprometimento do estado geral — cartaz 2023: **azitromicina** (até 30 kg: 10 mg/kg no 1º dia + 5 mg/kg/d por 4 d) ou ceftriaxona 50 mg/kg 3–5 d; > 30 kg: cipro 500 mg 12/12 h 3 d · cartaz antigo: ciprofloxacino 15 mg/kg 12/12 h 3 d. Loperamida contraindicada (disenteria, criança). Também cólera grave, imunossuprimido, giárdia/ameba. Ondansetrona (dose única) pode facilitar a TRO.

✎ ***Planos caíram nas 3 turmas**: T11 Q5 e APF (irritado + olhos fundos + bebe avidamente → Plano B na unidade) · T10 Q6 (sonolento, não bebe, TEC 4 s, pulso fino → Plano C) · T9 Q5 (vomitou e ficou letárgico → EV com SF 30 mL/kg; "soro glicofisiológico 1:1 100 mL/kg" é o esquema antigo).*

✎ *APF T11: o suplemento recomendado é o zinco (não probiótico) · APF T12: zinco 10–14 dias, 10 mg < 6 m / 20 mg ≥ 6 m (✗ "máximo 3 dias") · Shigella → cipro ou azitro + contraindicar loperamida.*

✗ *APF (discursiva Plano A): volume por evacuação de 1–10 anos é **100–200 mL** (erro comum: 50 mL). Receita completa: SRO (nome, 1 envelope/1 L, volume por evacuação) + zinco (dose, 1×/dia, 10–14 d) + alimentação habitual e líquidos caseiros + ≥ 4 sinais de retorno.*

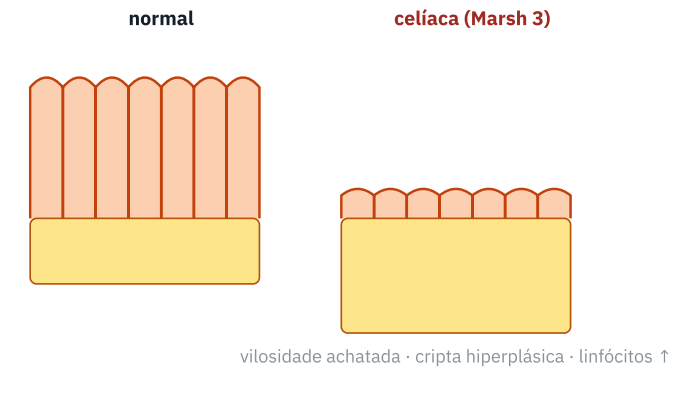
DIARREIA AGUDA NO ADULTO

- Sem gravidade: avaliar desidratação, duração e características das fezes; exames só nos graves; hidratação oral + eletrólitos + dieta leve conforme aceitação. Exames (coprocultura, leucócitos fecais, C. difficile) se: sangue, febre alta, desidratação grave, > 7 dias, imunossuprimido, idoso, surto, uso recente de ATB.
- ATB empírico (cipro 500 mg 12/12 h 3 d ou azitromicina 1 g DU): diarreia invasiva grave, febre alta, sangue — quando não dá para esperar o agente. Loperamida: evitar se sangue/febre.

✎ *T10 Q5: palavras que denunciam a errada → "de rotina", "em todos os casos", "restringir/suspender líquidos".*

DOENÇA CELÍACA E DIARREIA CRÔNICA

Doença celíaca: do glúten à biópsia



Suspeita: diarreia crônica fétida, distensão, baixo ganho, anemia — após pães e massas

↓

Anti-transglutaminase IgA + IgA total
(IgA baixa → testes IgG)

↓

EDA + biópsia duodenal ≥ 4 fragmentos (+ bulbo)
= padrão-ouro

↓

Dieta SEM glúten por toda a vida + Fe, folato, vitaminas

Exames COM glúten na dieta — sem glúten = falso-NEGATIVO

- Enteropatia autoimune ao **glúten** (trigo, centeio, cevada) em predispostos (HLA-DQ2/DQ8): atrofia de vilosidades + hiperplasia (alongamento) de criptas + linfócitos intraepiteliais (Marsh) → má absorção no duodeno/jejuno proximal (**ferro, folato, cálcio**).

- Clássica (criança após introdução de pães/massas): diarreia crônica com fezes volumosas, pastosas, fétidas; distensão/abdome globoso; perda de peso; baixo ganho estatural; palidez; irritabilidade. Extraintestinal: anemia ferropriva, osteopenia, atraso de crescimento/puberdade, infertilidade, neurológicas, dermatite herpetiforme, hipoplasia de esmalte.
- Diagnóstico: anti-transglutaminase tecidual IgA + IgA total (antiendomísio confirma) → EDA com biópsia duodenal = padrão-ouro (≥ 4 fragmentos da 2ª porção + 1–2 do bulbo). Tudo EM VIGÊNCIA de glúten (sem glúten = **falso-negativo**).
- Tratamento: dieta isenta de glúten por toda a vida + nutricionista + repor ferro, folato, vitaminas, cálcio. A mucosa **se recupera** com a dieta.
- Complicações sem tratamento: desnutrição, baixa estatura, osteoporose, infertilidade, celíaca refratária, **linfoma T associado à enteropatia**, adenocarcinoma de delgado.
- Intolerância à lactose: osmótica, distensão e flatulência após leite → teste do H_2 expirado → restringir/substituir, lactase.

✎ ***Celíaca caiu 2× em discursiva (T9 e T10) + 1 objetiva (T9 Q4).*** *Na T9 Q4 eram falsas: "recuperação parcial" e* "biópsia após 6 semanas SEM glúten para evitar falso-positivo".

PARASITOSES

- Dica dos tutores: saber se é protozoário, nematódeo ou cestódeo — o grupo já aponta o remédio (protozoário → nitroimidazol; nematódeo → albendazol/ivermectina; cestódeo → praziquantel).

Parasitoses: primeiro, que bicho é

PROTOZOÁRIOS — unicelulares

Giardia
diarreia persistente, esteatorreia, creche
→ metronidazol 5–7 d · secnidazol/tinidazol DU

Entamoeba
disenteria, abscesso hepático
→ metronidazol 7–10 d + luminal

NEMATÓDEOS — vermes cilíndricos

Ascaris
bolo de vermes → suboclusão em criança
→ albendazol DU · suboclusão: CONSERVADOR + óleo mineral

Ancilóstomo
descalço → anemia ferropriva
→ albendazol DU + ferro

Strongyloides
corticoide → hiperinfecção + sepse gram –
→ IVERMECTINA

Enterobius
prurido anal noturno · fita adesiva
→ albendazol DU, repetir em 2 sem + família

CESTÓDEOS — vermes achatados (fita)

Taenia
come cisticerco (carne) → teníase
→ praziquantel DU

Cisticercose
come o OVO (T. solium) → neurocisticercose
→ neuroimagem; albendazol + corticoide

Parasita	Pista	Diagnóstico	Tratamento
Enterobius (oxiúro)	**prurido anal noturno**, escoriações, criança, família	**fita adesiva (Graham)**	**albendazol 400 mg DU, REPETIR em 2 semanas** + tratar todos da casa
Ascaris	dor, Löffler; **bolo de vermes → suboclusão em criança** (massa, vômitos biliosos, vermes pela boca)	EPF, RX	albendazol 400 mg DU · **suboclusão: CONSERVADOR** (jejum, SNG, hidratação, **óleo mineral**); verme só depois; cirurgia se falha/perfuração
Ancilostomídeos	descalço, **anemia ferropriva** (espoliação), geofagia	EPF	albendazol 400 mg DU + ferro
Strongyloides	larva currens; **corticoide em dose alta → hiperinfecção: diarreia, lesões de pele, SEPSE por gram-negativo**/HTLV	Baermann-Moraes	**ivermectina 200 µg/kg** (1–2 d) · albendazol 400 mg 3 d

Giardia	diarreia persistente, **esteatorreia/má absorção**, creche	EPF seriado, Ag fecal	metronidazol 250 mg 8/8 h 5–7 d (15 mg/kg/d) · secnidazol/tinidazol 2 g DU
Entamoeba	disenteria, abscesso hepático	EPF, sorologia, USG	metronidazol 500–750 mg 8/8 h 7–10 d + luminal
Taenia	**comeu CISTICERCO (carne crua) → TENÍASE; comeu o OVO (T. solium, fezes humanas) → CISTICERCOSE/neurocisticercose**	EPF/tamisação · neuroimagem	praziquantel 5–10 mg/kg DU · neurocisticercose: albendazol + corticoide

- OMS: geo-helmintos > 20% → tratamento em massa 1×/ano; > 50% → 2×/ano (albendazol/mebendazol); não substitui saneamento e educação.

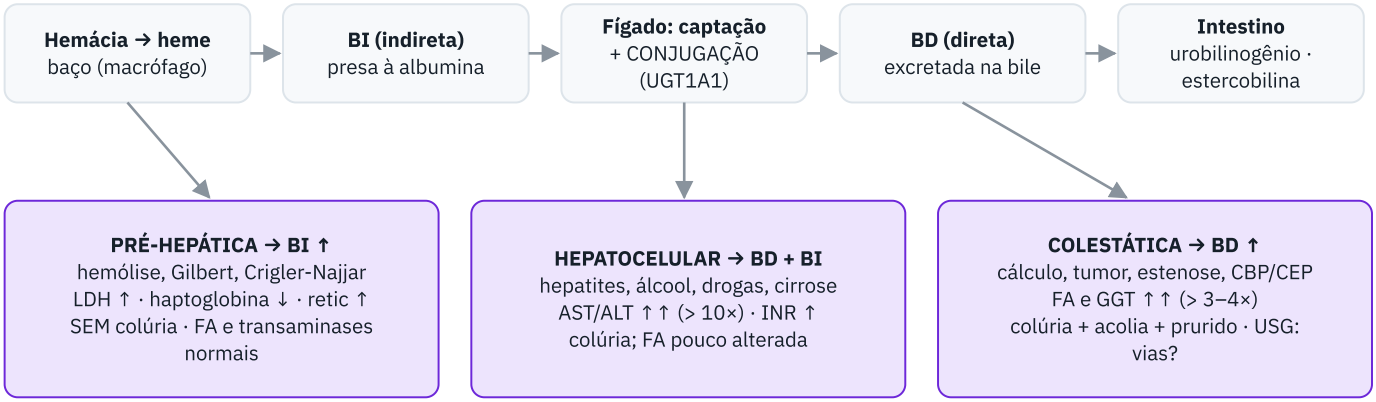
✎ *T11 discursiva 2: prurido anal noturno →* enterobíase · fita adesiva (Graham) · albendazol DU repetido em 2 semanas · tratar a família · unhas curtas, lavar mãos, roupas de cama em água quente. *Quem escreveu "albendazol 14 dias" perdeu o item. Diarreia de 20 dias =* persistente.

✗ *Erros na APF T12:* ***Strongyloides*** *(erro comum: Ancylostoma; pista = corticoide + sepse → ivermectina) ·* ***áscaris com suboclusão*** *(erro comum: laparotomia; é* conservador *— dica da tutora também) ·* ***teníase × cisticercose*** *(carne → tênia; ovo → cisticercose).*

SP3 · ICTERÍCIA, VIAS BILIARES E PÂNCREAS

ICTERÍCIA: TIPOS E CAUSAS

Bilirrubina: onde o fluxo trava define o tipo de icterícia



- Icterícia visível com BT > 2–3 mg/dL (escleras primeiro). Pergunta dos tutores: "se tem icterícia, quais doenças pode ter?" — responda pelos 3 grupos:

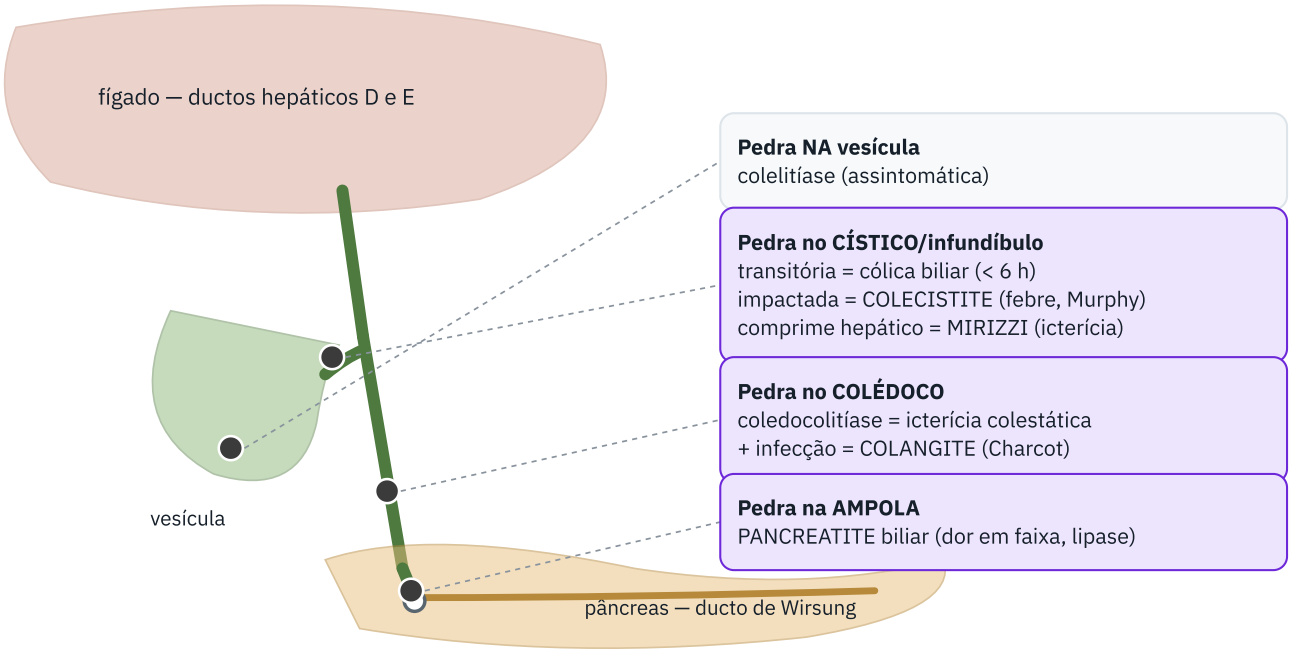
Tipo	Causas (cite 5)	Laboratório
Indireta (pré-hepática)	hemólise (esferocitose, falciforme, G6PD, autoimune), **Gilbert**, Crigler-Najjar, reabsorção de hematoma, eritropoese ineficaz, icterícia neonatal, rifampicina	BI ↑, LDH ↑, haptoglobina ↓, reticulócitos ↑; **sem colúria**; FA/transaminases normais
Hepatocelular	hepatites virais (A, B, C, E), alcoólica, medicamentosa (paracetamol), autoimune, cirrose, Wilson, isquêmica	**AST/ALT ↑↑ (> 10×)**, BD e BI, INR ↑, albumina ↓
Direta / colestática	coledocolitíase , tumor de cabeça de pâncreas/periampular, colangiocarcinoma, estenose biliar, Mirizzi, CEP/CBP, colestase da gravidez, drogas, Dubin-Johnson, Rotor	**BD ↑, FA e GGT ↑↑**, colúria, acolia, prurido; USG: vias dilatadas (extra-hepática)

- Causas de obstrução do colédoco: cálculo, tumor periampular/pâncreas, colangiocarcinoma, estenose benigna (pós-operatória, pancreatite crônica), Mirizzi, cisto de colédoco, parasita (áscaris), compressão por linfonodo.
- Função hepática (tutor): plaquetas, TAP/INR, albumina, bilirrubina, amônia — transaminases e FA são **lesão**, não função.
- Gilbert: jovem, icterícia leve após jejum/estresse/virose, só BI ↑, resto normal → benigno, não trata. **Courvoisier-Terrier**: vesícula palpável indolor + icterícia progressiva = tumor periampular (não cálculo).

✎ *T11 Q9:* indireta — hemólise; direta — coledocolitíase · *T9 discursiva 3:* cite 5 causas de BD e 5 de BI + 5 de obstrução do colédoco · *T11 discursiva 3: diga* qual exame sobe em cada tipo *(a corretora anotou isso).*

A ÁRVORE BILIAR: NÃO CONFUNDA AS DOENÇAS

Onde está a pedra define a doença



Doença	Dor	Febre	Icterícia	Lab / imagem	Conduta
Cólica biliar	HD/epigástrio pós-gordura, **< 6 h**, passa	não	não	normais · USG cálculo	colecistectomia eletiva
Colecistite aguda	HD > 6 h, **Murphy +**	sim	não/leve	leucocitose · **USG: parede > 4 mm, líquido**	ATB + **colecistectomia VLP precoce**
Coledocolitíase	cólica biliar	não	**sim, flutua**	BD, FA, GGT ↑ · colédoco > 6 mm	**CPRE + colecistectomia**
Colangite	HD	**sim + calafrios**	sim	Charcot ± choque/confusão (Reynolds)	ATB + **drenagem biliar (CPRE)**
Pancreatite biliar	**epigástrio em faixa → dorso**	pode (SIRS)	às vezes	**lipase ≥ 3×**, ALT > 150	suporte; CPRE se colangite; colecistectomia
Mirizzi	de colecistite	±	sim	cálculo no infundíbulo comprimindo o hepático comum	cirurgia
Tumor periampular	indolor/emagrecimento	não	**progressiva**	Courvoisier, CA 19-9, TC	estadiar

- Síndrome de Mirizzi: cálculo impactado no infundíbulo/cístico comprimindo o hepático comum → icterícia obstrutiva (APF T12). Cálculo que migrou e passou: icterícia e transaminases que sobem e caem sozinhas, colédoco normal (APF T12).

✎ Tutores: "SP3, cuidado para não confundir as doenças". *Erro nº 1 da turma:* colangite → colecistectomia *(T11 Q12 e discursiva). Colangite =* ***drenar a via (CPRE)****; colecistite =* ***tirar a vesícula****.*

CRITÉRIOS DE TÓQUIO (TG18)



	Colecistite aguda	Colangite aguda
A	**Local**: Murphy; massa/dor/defesa em QSD	**Inflamação sistêmica**: febre > 38 °C/calafrios; leucócitos < 4 ou > 10 mil, PCR ≥ 1
B	**Sistêmico**: febre, PCR ↑, leucocitose	**Colestase**: icterícia (BT ≥ 2) ou FA/GGT/AST/ALT > 1,5× LSN
C	**Imagem** característica (USG)	**Imagem**: dilatação biliar ou etiologia (cálculo, estenose, stent)
Suspeita	A + B	1 de A + 1 de B ou C
Definitivo	A + B + C	A + B + C
Grau III	**disfunção orgânica**: hipotensão com vasopressor · rebaixamento de consciência · PaO_2/FiO_2 < 300 · oligúria/Cr > 2 · INR > 1,5 · plaquetas < 100 mil	
Grau II	leucócitos > 18 mil, massa palpável, > 72 h, inflamação local marcada (gangrenosa, enfisematosa, abscesso, peritonite biliar)	2 de: leuco > 12 mil ou < 4 mil, febre ≥ 39 °C, idade ≥ 75, BT ≥ 5, hipoalbuminemia
Conduta	I: VLP precoce · II: VLP precoce (centro experiente) ou drenagem · III: suporte + **colecistostomia percutânea**, cirurgia depois	I: ATB (drenar se não melhorar em 24 h) · II: ATB + **drenagem precoce** · III: ressuscitação + ATB + **drenagem urgente**

- Tríade de Charcot (dor em HD + febre + icterícia) + hipotensão + confusão = pêntade de Reynolds = colangite grave.

✎ *APF T12: febre + leucócitos + PCR + BT 4,3 + colédoco com cálculo =* colangite DEFINITIVA *(não precisa da tríade completa).*

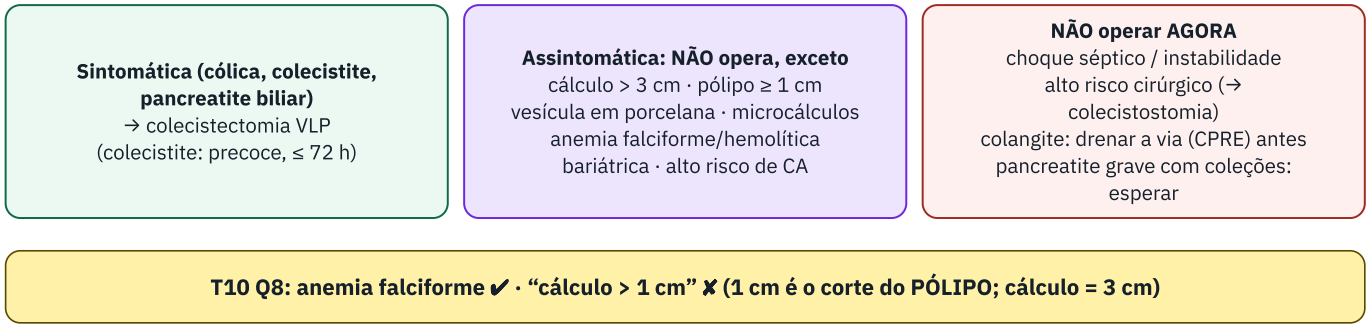
✗ *APF T12: noradrenalina + confusão + Cr 2,5 + plaquetas 90 mil + cálculo no colédoco =* ***colangite grau III → suporte + drenagem biliar urgente*** *(erro comum: colecistite grau III + colecistectomia — o mesmo erro da T11).*

✎ *T9 Q9 e T10 Q9: Charcot (± choque/confusão) →* colangite → ATB + drenagem da via biliar *· T11 Q12: Reynolds →* ATB amplo + CPRE urgente, tratamento definitivo da causa após estabilizar.

COLELITÍASE E COLECISTITE: CONDUTA

- Fatores de risco: mulher, > 40 a, obesidade, gestação/multiparidade, emagrecimento rápido, história familiar, hemólise (cálculo pigmentar). Assintomático: **não opera**, exceto as indicações abaixo.

Vesícula: quando operar e quando NÃO operar agora



T10 Q8: anemia falciforme ✔ · "cálculo > 1 cm" ✘ (1 cm é o corte do PÓLIPO; cálculo = 3 cm)

Ácido ursodesoxicólico (8–10 mg/kg/dia): só cálculo pequeno, radiotransparente, em quem não pode operar — dissolve em 6–24 meses

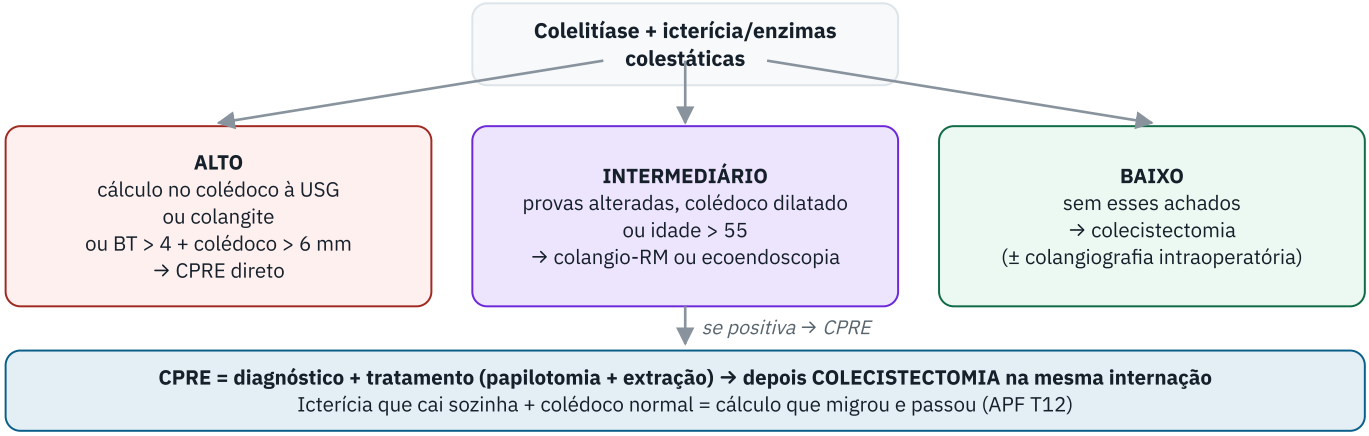
Acalculosa: paciente grave/UTI, jejum prolongado, nutrição parenteral · enfisematosa: idoso diabético (Clostridium)

- Colecistectomia no ASSINTOMÁTICO: anemia hemolítica (falciforme), **cálculo > 2,5–3 cm**, pólipo ≥ 1 cm (ou crescendo, > 50 a, com cálculo), vesícula em porcelana, microcálculos, anomalia da junção pancreatobiliar, alto risco de CA (indígenas, região endêmica), antes de transplante/bariátrica (considerar).
- NÃO operar agora (dica da tutora): choque séptico/instabilidade, alto risco cirúrgico (→ colecistostomia percutânea), colangite (drena a via antes), pancreatite grave com coleções; assintomático sem as indicações acima.
- Colecistite: USG = exame inicial e de escolha (cintilografia se dúvida). Hidratação + analgesia + ATB + colecistectomia VLP precoce na mesma internação (ideal ≤ 72 h, até 7–10 d). Alto risco cirúrgico/grau III: colecistostomia percutânea.

✎ *T10 Q8:* anemia falciforme *— quem marcou "cálculo > 1 cm" errou (1 cm é corte de* ***pólipo****) · APF: pólipo 2,3 cm aos 87 a →* colecistectomia *· T11 Q10:* VLP na mesma internação *· T11 Q11:* USG*.*

COLEDOCOLITÍASE: QUEM VAI DIRETO PARA CPRE

Suspeita de coledocolitíase: risco (ASGE) define o exame

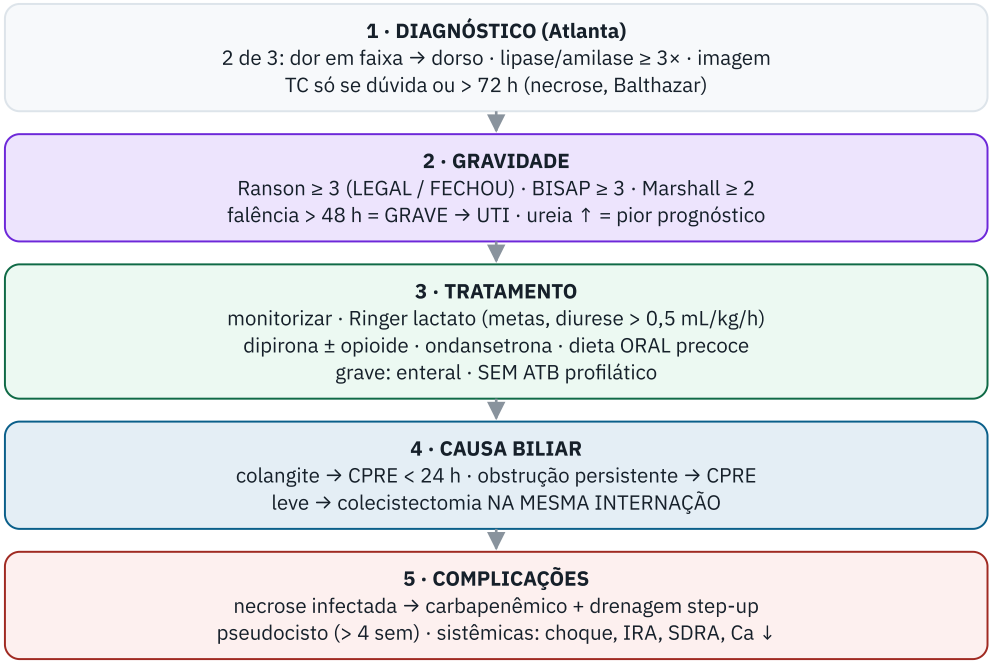


- Risco (ASGE): **alto** = cálculo no colédoco à USG, colangite, ou BT > 4 + colédoco dilatado (> 6 mm) → **CPRE** (diagnóstica e terapêutica: papilotomia + extração). **Intermediário** (provas alteradas, colédoco dilatado, > 55 a) → **colangio-RM ou ecoendoscopia** antes. Baixo → colecistectomia (± colangiografia intraoperatória).
- Conduta: internar · labs seriados (BT/frações, FA, GGT, TGO/TGP, INR, amilase/lipase, hemograma, PCR) · colangio-RM/eco-EDA se dúvida · CPRE · colecistectomia VLP na mesma internação. Complicações: colangite, pancreatite biliar, abscesso hepático, cirrose biliar secundária, coagulopatia.

✎ *T9 discursiva 3 (icterícia + colédoco 11 mm, "sem fator obstrutivo ao método"): a nota baixa foi de quem escreveu só "CPRE". Responda* ***regime (hospitalar) + exames + tratamento (CPRE + colecistectomia)****.*

PANCREATITE AGUDA

Pancreatite aguda: do diagnóstico à prevenção



- Causas: litíase biliar e álcool (~80%), hipertrigliceridemia (> 1.000), pós-CPRE, drogas, trauma, hipercalcemia, tumor. Biliar: cálculos + ALT > 150 + colestase + colédoco dilatado, sem álcool.
- Atlanta: 2 de 3 — dor típica (epigástrio em faixa → dorso), lipase/amilase ≥ 3× LSN, imagem característica. Lipase é mais específica e dura mais que a amilase. Enzimas NÃO medem gravidade.
- TC com contraste: melhor exame do pâncreas, mas NÃO na admissão — só se dúvida diagnóstica ou após 72–96 h (necrose, piora). USG na admissão = procurar cálculo (etiologia).
- **Gravidade**: Atlanta pela falência orgânica (Marshall ≥ 2 em respiratório, renal ou cardiovascular) — leve (sem falência/complicação) · moderadamente grave (falência < 48 h e/ou complicação local) · grave (falência **persistente > 48 h**). Ranson ≥ 3 = grave — admissão **LEGAL**: Leucócitos > 16 mil · Edade > 55 · Glicose > 200 · AST > 250 · LDH > 350; 48 h: queda de Ht > 10%, ↑ ureia > 5, Ca < 8, PaO_2 < 60, déficit de bases > 4, sequestro > 6 L. BISAP ≥ 3 (ureia/BUN, consciência, SIRS, idade > 60, derrame pleural), PCR > 150 em 48 h.
- Do tutor (vai cair): Ranson "LEGAL" na admissão e "FECHOU" em 48 h — **F**luido sequestrado > 6 L · **E**xcesso (déficit) de base > 4 · **C**álcio < 8 · **H**ematócrito cai > 10% · **O**$_2$ (PaO_2 < 60) · **U**reia sobe > 5. Mortalidade: 0–2 ≈ 1–5% · 3–4 ≈ 15–20% · 5–6 ≈ 40% · ≥ 7 muito alta. Ureia (BUN) alta = pior prognóstico · lipase NÃO tem relação com gravidade · Marshall = falência renal, cardiovascular e respiratória · Atlanta separa complicação local × sistêmica · TC de Balthazar após 48–72 h para necrose.
- Protocolo de tratamento: monitorização · jejum inicial · Ringer lactato · dipirona 1 g EV 6/6 h (± opioide) · ondansetrona 4 mg EV 8/8 h · profilaxia de TEV · controle glicêmico · diurese. Hidratação **moderada guiada por metas** (Ringer ~1,5 mL/kg/h; bolus 10 mL/kg se hipovolêmico — WATERFALL 2022); vigorosa importa nas primeiras 12–24 h. Dieta VO/enteral precoce (24–72 h) conforme tolerância — enteral, não parenteral. Resumo do tutor: "ressuscitação precoce e vigorosa com Ringer, 15–20 mL/kg e depois 250 mL/h, diurese > 0,5 mL/kg/h; jejum inicial → dieta leve precoce".

*✗APF T12: na leve, **dieta oral precoce conforme tolerância, pobre em gordura** (erro comum: "jejum até normalizar a lipase"). A lipase não guia a realimentação.*

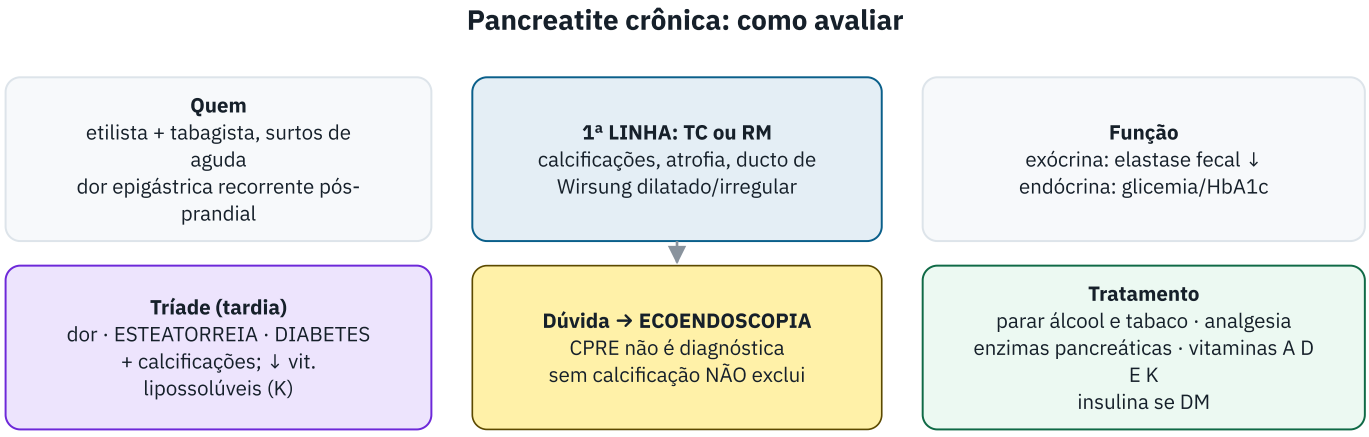
- ATB profilático: NÃO. Só se **necrose infectada** (gás, piora após 7–10 d) ou infecção extrapancreática → **carbapenêmico (meropenem 1 g 8/8 h)** + drenagem/necrosectomia em step-up (≥ 4 semanas).
- **Local**: Ranson ≥ 3 / falência / SIRS persistente → UTI. **CPRE**: urgente (< 24 h) se colangite; se obstrução persistente. **Colecistectomia**: na mesma internação (leve); grave com coleções → após resolução (~6 semanas).

- Complicações LOCAIS: coleção peripancreática aguda, **pseudocisto** (> 4 semanas, parede), necrose (estéril/**infectada**), walled-off necrosis, abscesso, trombose de v. esplênica/porta, pseudoaneurisma, ascite pancreática. SISTÊMICAS: SIRS/choque, **IRA**, **SDRA**/derrame pleural, CIVD, **hipocalcemia**, hiperglicemia, sepse, falência de múltiplos órgãos.

✎ *T9 Q7: falsas → "amilase mais específica que lipase", "parenteral precoce" (as vantagens são da ENTERAL), "RM é padrão-ouro" · T9 Q8: hidratação + monitorar órgãos (Marshall); ATB profilático, colecistectomia imediata e cirurgia de 1ª linha = erradas · T10 Q7: monitorização, jejum, Ringer, dipirona, ondansetrona.*

✎ *T10 discursiva 3: Ranson 4 → UTI (quem pôs enfermaria zerou) · complicações citadas como DM, esteatorreia e calcificação = **crônica**, não aguda.*

PANCREATITE CRÔNICA: COMO AVALIAR



Na AGUDA, DM/esteatorreia/calcificação não são complicações — são da CRÔNICA (erro da T10)

- Dica da tutora: como avaliar pancreatite crônica — TC ou RM = 1ª linha (calcificações, atrofia, Wirsung dilatado); **ecoendoscopia se dúvida**; CPRE não é diagnóstica; **ausência de calcificação não exclui**; função exócrina = elastase fecal; tutor: "achado = calcificação + ↓ vitamina K (má absorção de gordura)".

✗ *APF T12: erro comum: "ecoendoscopia obrigatoriamente como primeiro exame" — certa era **TC ou RM como primeira linha**.*

HEPATITES E CIRROSE

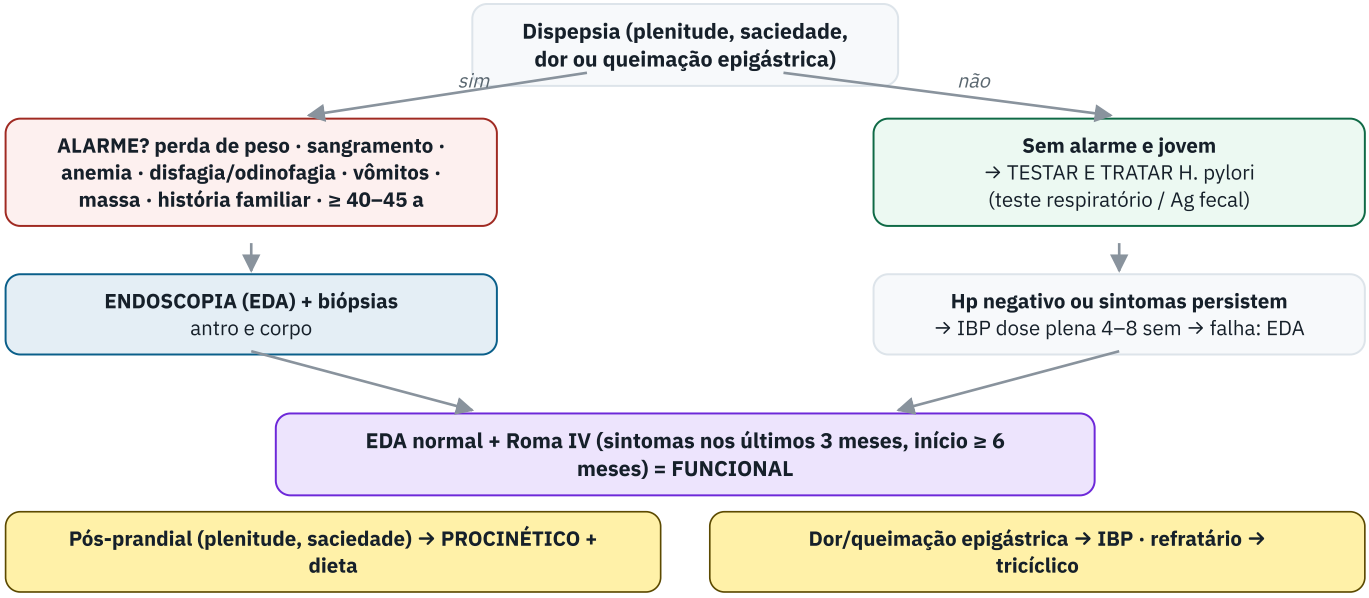
Perfil HBV	Interpretação
HBsAg + · anti-HBc IgM +	hepatite B **aguda**
HBsAg + · anti-HBc IgG + (> 6 m)	**crônica** (HBeAg + = replicação)
HBsAg – · anti-HBc + · anti-HBs +	infecção **passada, curada**
HBsAg – · anti-HBc – · anti-HBs +	**vacinado**
HBsAg – · anti-HBc + isolado	janela, oculta ou falso + → investigar (HBV-DNA)

- A e E: fecal-oral, agudas (E grave na gestante). C: parenteral, cronifica (~80%), tratamento com antivirais de ação direta. Cirrose: ascite (PBE: PMN > 250 → ceftriaxona/cefotaxima + albumina), varizes, encefalopatia, Child-Pugh/MELD.

SP4 · DISPEPSIA, DRGE, ÚLCERA E HDA

DISPEPSIA E SINAIS DE ALARME

Dispepsia: alarme → EDA; sem alarme → testar e tratar

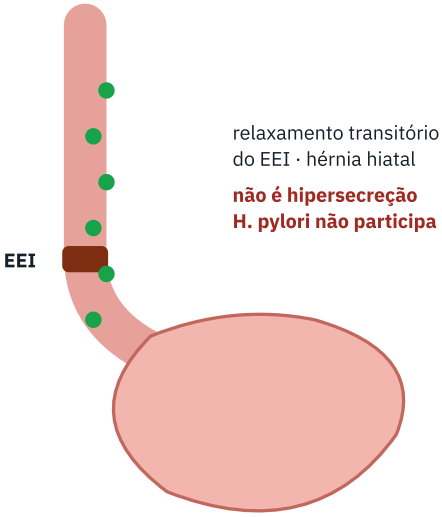


- Quando o Roma IV define dispepsia FUNCIONAL (dica da tutora): ≥ 1 sintoma (plenitude pós-prandial, saciedade precoce, dor ou queimação epigástrica) + sem doença estrutural que explique (EDA normal) + presentes nos últimos 3 meses com início ≥ 6 meses antes. Subtipos: desconforto pós-prandial (≥ 3 d/sem) e dor epigástrica (≥ 1 d/sem).
- Roma IV: plenitude pós-prandial, saciedade precoce, dor ou queimação epigástrica. Funcional = sem doença estrutural (EDA normal) que explique; mecanismos: esvaziamento lento, falha de acomodação do fundo, hipersensibilidade visceral, inflamação duodenal, eixo cérebro-intestino.
- Alarme → EDA: perda de peso, sangramento (hematêmese, "borra de café", melena), anemia, disfagia/odinofagia, vômitos persistentes, massa, linfonodo, história familiar de CA gástrico, início ≥ 40–45 a (Brasil).
- Sem alarme e jovem: **test-and-treat H. pylori** (até 45 a) ou IBP empírico.
- Dispepsia funcional — tratamento pelo subtipo: plenitude/saciedade (desconforto pós-prandial) → PROCINÉTICO + dieta · dor/queimação epigástrica → IBP 4–8 sem; H. pylori + → erradicar; refratário → antidepressivo tricíclico em dose baixa.

✎ *T11 Q13: plenitude + distensão, EDA e Hp negativos →* procinético + medidas dietéticas *(IBP era o distrator) · T10 Q11:* motilidade + hipersensibilidade visceral *· T9 Q11:* perda de 5 kg → EDA *· APF: alarme =* vômito em borra de café*.*

DRGE

DRGE: IBP primeiro; exame para quem não responde



Pirose + regurgitação, sem alarme
→ IBP dose plena 4–8 sem + medidas (peso, cabeceira, não deitar após comer)

Alarme, refratário, idade, longa duração (Barrett) → EDA

EDA normal + sintomas → pHmetria 24 h / pH-impedância SEM IBP (7 dias)
= padrão-ouro para provar o refluxo

Manometria: antes da fundoplicatura (afasta acalasia) — NÃO diagnostica DRGE

Dor torácica em queimação + ECG/troponina normais → IBP

- Mecanismo principal: relaxamentos transitórios do EEI (+ EEI hipotônico, hérnia hiatal, depuração ruim, esvaziamento lento). Obesidade, gordura, álcool, refrigerante, tabaco, deitar após comer pioram. H. pylori NÃO está relacionado à fisiopatologia da DRGE (dica da tutora; erradicar não piora o refluxo).
- Típica: pirose + regurgitação, pós-prandial e ao deitar. Atípicas: tosse, rouquidão, asma, dor torácica não cardíaca (afastar SCA primeiro).
- Sem alarme → IBP dose plena 4–8 semanas como teste terapêutico + medidas (perder peso, elevar a cabeceira, não deitar 2–3 h após comer). EDA: alarme, refratário, ≥ 40–45 a, longa duração (Barrett). pHmetria 24 h (padrão-ouro) com IBP suspenso ~7 dias: sintomas que voltam após suspender/atípicos/antes de cirurgia. **Manometria**: antes de fundoplicatura (afastar acalasia) — não para diagnosticar DRGE.
- Barrett: metaplasia intestinal → vigilância endoscópica; complicações: esofagite, estenose, Barrett, adenocarcinoma.

✎ *T9 Q10:* relaxamento transitório do EEI *· T9 Q12: dor torácica em queimação, ECG/troponina normais →* IBP *· T11 Q14: pirose sem alarme →* IBP 4–8 sem *· T10 Q10: volta após suspender →* pHmetria após 7 dias sem IBP *· APF T12:* RTEEI + hérnia hiatal; IBP antes da refeição + medidas *(✗hipersecreção, ✗manometria inicial) e refratário sem DRGE comprovada →* pHmetria/pH-impedância SEM IBP*.*

ÚLCERA PÉPTICA

Úlcera duodenal × gástrica

DUODENAL	GÁSTRICA
H. pylori + hipersecreção ácida	AINE + H. pylori · ácido normal/baixo
dor MELHORA com a comida	dor PIORA com a comida · emagrece
volta 2–3 h depois · acorda de madrugada	pode ser CÂNCER → biopsiar sempre
não maligniza	suspeita (bordas elevadas): aguardar histopatológico
controle: teste respiratório (sem nova EDA)	controle: EDA com biópsia em 8–12 sem
IBP 4 semanas	IBP 8 semanas

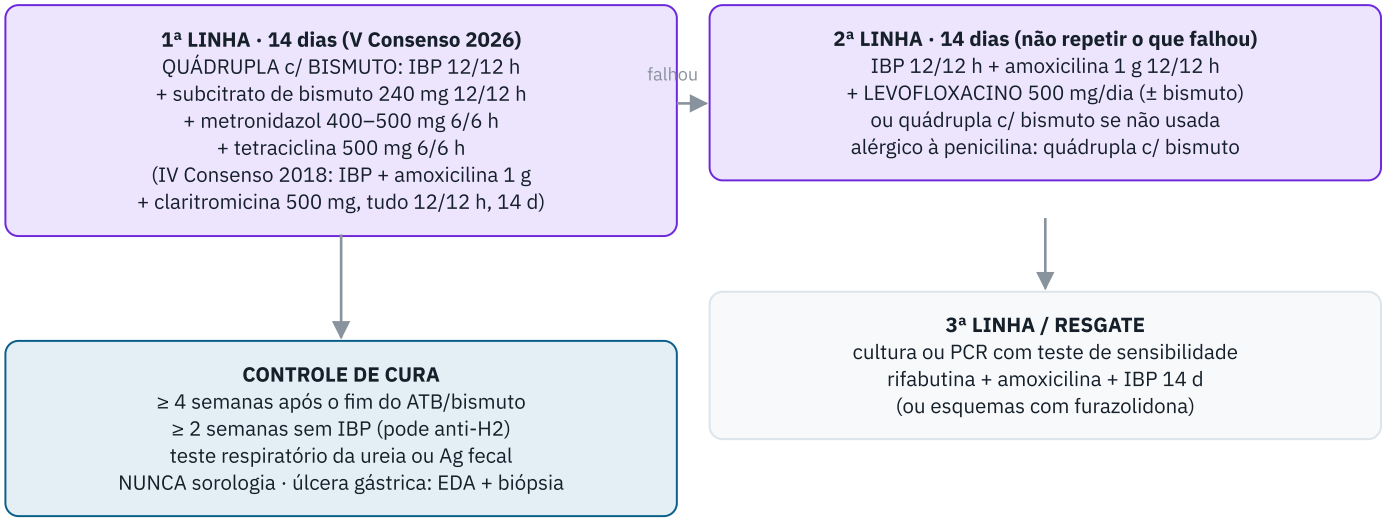
AINE inibe COX → ↓ prostaglandina → ↓ muco, bicarbonato, fluxo e reparo da mucosa

- Tratamento (início, dose, indicação): suspender AINE/AAS, álcool e tabaco · **erradicar H. pylori se positivo** (toda úlcera infectada) · IBP dose plena: omeprazol 20 mg ou pantoprazol 40 mg 1×/dia em jejum — duodenal 4 sem (até 8), gástrica 8 sem (até 12) · AINE indispensável → IBP contínuo ou coxibe + IBP.
- Úlcera gástrica de aspecto suspeito (bordas elevadas, fundo irregular, perda de peso): aguardar histopatológico; benigna → IBP (± sucralfato) e EDA de controle; maligna → estadiar/gastrectomia.
- Complicações: hemorragia (a mais comum), perfuração, penetração (pâncreas), obstrução/estenose pilórica (vômitos, alcalose hipoclorêmica hipocalêmica) — e anemia ferropriva.

✎ *T10 Q12:* duodenal = hipersecreção + H. pylori; gástrica = também AINE *(a errada invertia "melhora/piora com a comida")* · *T11 Q15:* aguardar histopatológico · *APF: AINE →* úlcera/sangramento · *APF T12:* AINE inibe COX → ↓ prostaglandinas → ↓ muco, bicarbonato, fluxo e reparo*; quádrupla com bismuto 14 d = opção recomendada; perfuração = ressuscitação + jejum + ATB + cirurgia.*

H. PYLORI: DIAGNÓSTICO, LINHAS E CONTROLE

H. pylori: 1ª → 2ª → 3ª linha → controle de cura



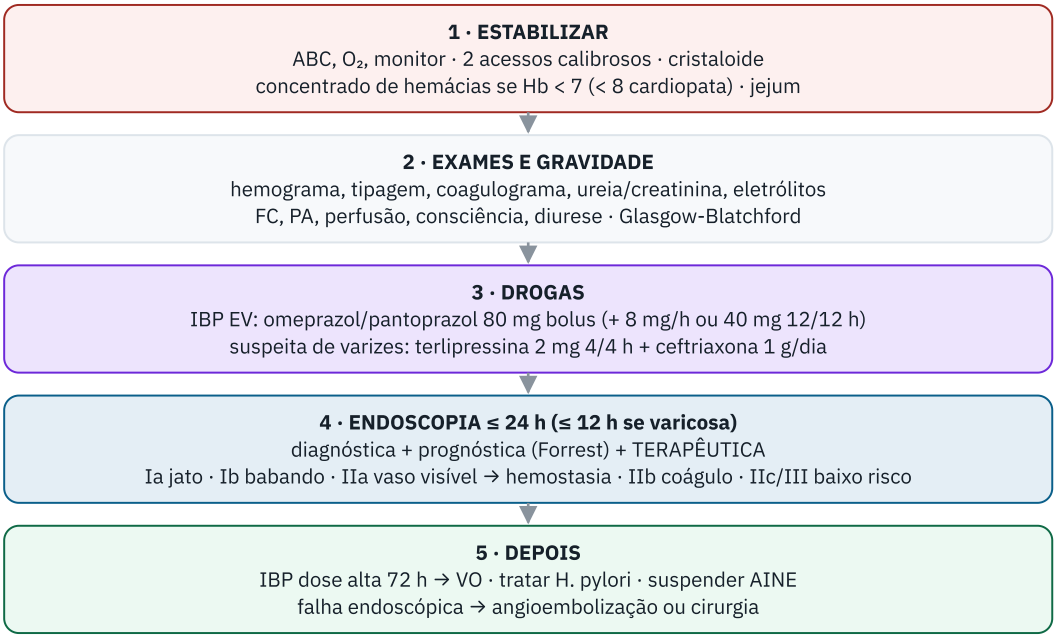
- Testes: invasivos (EDA) — **urease na biópsia**, histologia, cultura/PCR (sensibilidade); não invasivos — **teste respiratório com ureia marcada** (melhor), **antígeno fecal**, sorologia (só contato prévio; **nunca para controle**). **Suspender IBP 14 dias e ATB/bismuto 4 semanas** antes do teste (falso-negativo).
- 1ª linha (V Consenso Brasileiro 2026): quádrupla com bismuto, 14 dias — IBP 12/12 h (ou vonoprazana 20 mg 12/12 h) + subcitrato de bismuto 240 mg 12/12 h + metronidazol 400–500 mg 6/6 h + tetraciclina 500 mg 6/6 h. Ainda muito cobrada (IV Consenso 2018): tríplice — IBP 12/12 h + amoxicilina 1 g 12/12 h + claritromicina 500 mg 12/12 h por 14 dias. Na T11 a tutora aceitou as duas.
- 2ª linha (14 dias; nunca repetir o que falhou): IBP 12/12 h + amoxicilina 1 g 12/12 h + **levofloxacino 500 mg 1×/dia** (± bismuto), ou quádrupla com bismuto se ainda não usada.
- 3ª linha / resgate: guiada por **cultura/PCR com teste de sensibilidade**; rifabutina + amoxicilina + IBP 14 d (ou esquemas com furazolidona). **Alérgico à penicilina**: quádrupla com bismuto.
- Orientar: metronidazol = gosto metálico e efeito antabuse (sem álcool) · bismuto = **fezes pretas (não é melena)** · tetraciclina não em gestante/< 8 a, longe de leite/antiácido · claritromicina = interações (CYP3A4).
- Controle de cura: teste respiratório (ou Ag fecal) ≥ 4 semanas após o fim do tratamento e ≥ 2 semanas sem IBP; nunca sorologia; úlcera gástrica → EDA com biópsia.

✎ *APF T12:* teste respiratório ou Ag fecal ≥ 4 semanas após ATB/bismuto, IBP suspenso ~2 semanas *(✗melhora dos sintomas, ✗sorologia, ✗"mantendo o omeprazol").*

✎ *T11 Q16:* teste respiratório ≥ 4 semanas após o término · *T11 discursiva 4:* úlcera duodenal + urease + — tratamento com DROGA + DOSE + INTERVALO + DURAÇÃO, IBP até cicatrizar, ferro; seguimento com teste em 4 semanas; complicações.

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Hemorragia digestiva alta: a ordem do manejo



- HDA = acima do ângulo de Treitz: hematêmese, "borra de café", **melena** (ureia ↑ desproporcional à creatinina). Não varicosa: úlcera péptica (principal — AINE/H. pylori), gastrite erosiva, Mallory-Weiss, esofagite, neoplasia, Dieulafoy · Varicosa: varizes esofagogástricas (etilista/cirrose). Diagnósticos diferenciais (dica da tutora): úlcera péptica, varizes, Mallory-Weiss, esofagite/gastrite erosiva, câncer, Dieulafoy, angiodisplasia, fístula aortoentérica, hemobilia; e "falsa HDA": epistaxe deglutida, hemoptise, ferro/bismuto escurecendo as fezes.
- Gravidade: FC, PA (hipotensão postural), índice de choque, perfusão (TEC, extremidades frias), consciência, diurese, volume do sangramento; escores **Glasgow-Blatchford** (pré-EDA; ≤ 1 = alta) e Rockall.
- Protocolo emergencial: ABC · O_2 · monitor · 2 acessos calibrosos · cristaloide · transfusão restritiva (Hb < 7; < 8 se cardiopata) · jejum · labs (hemograma, tipagem/prova cruzada, coagulograma, ureia/creatinina, eletrólitos, função hepática, lactato) · IBP EV: omeprazol/pantoprazol 80 mg em bolus (+ 8 mg/h ou 40 mg 12/12 h) · eritromicina 250 mg EV pré-EDA · **suspeita de varizes: terlipressina 2 mg EV 4/4 h (ou octreotide) + ceftriaxona 1 g/dia** · suspender AINE.
- EDA: diagnóstica + prognóstica (Forrest) + TERAPÊUTICA, em até 24 h após estabilizar (≤ 12 h se varicosa ou alto risco). Forrest Ia (jato) / Ib (babando) / IIa (vaso visível) → tratar (adrenalina + térmico/clipe); IIb (coágulo) → remover e avaliar; IIc/III → baixo risco. Varizes → ligadura elástica.
- Após hemostasia de alto risco: IBP dose alta 72 h → VO 2×/dia até 14 d → 1×/dia. Pesquisar e tratar H. pylori.

✎ ***Discursiva de HDA caiu na T9 e na T10*** *(etilista + AINE, hematêmese, choque): causas (varicosa × não varicosa), abordagem/estabilização, gravidade,* papel e momento da EDA — sempre escrever a finalidade TERAPÊUTICA *(a corretora anotou "+ tratamento" nas duas).*

PROTOCOLOS E DOSES (O QUE OS TUTORES PEDIRAM)

IBP · ÚLCERA · H. PYLORI · HDA

Situação	Droga · dose · intervalo · tempo
IBP dose padrão (plena)	**omeprazol 20 mg · pantoprazol 40 mg** · lansoprazol 30 · esomeprazol 40 · rabeprazol 20 mg — 1×/dia, 30–60 min antes do café
Dose dobrada	a mesma dose 12/12 h: erradicação de H. pylori, DRGE refratária
DRGE / dispepsia (dor)	IBP dose plena 4–8 semanas, depois menor dose eficaz/sob demanda

Úlcera duodenal	erradicar Hp + IBP dose plena **4 semanas** (até 8)
Úlcera gástrica	erradicar Hp + IBP **8 semanas** (até 12) + EDA com biópsia em 8–12 sem
H. pylori 1ª linha	**Quádrupla c/ bismuto 14 d**: IBP 12/12 + bismuto 240 mg 12/12 + metronidazol 400–500 mg 6/6 + tetraciclina 500 mg 6/6 · ou **tríplice 14 d**: IBP 12/12 + amoxicilina 1 g 12/12 + claritromicina 500 mg 12/12
H. pylori 2ª linha	IBP 12/12 + amoxicilina 1 g 12/12 + **levofloxacino 500 mg/dia** (± bismuto) 14 d · ou quádrupla c/ bismuto
H. pylori 3ª linha	teste de sensibilidade (cultura/PCR) · rifabutina + amoxicilina + IBP 14 d
Controle de cura	teste respiratório/Ag fecal ≥ 4 sem após o fim · ≥ 2 sem sem IBP
HDA	**omeprazol/pantoprazol 80 mg EV bolus** + 8 mg/h (ou 40 mg EV 12/12 h) 72 h · varizes: terlipressina 2 mg 4/4 h + ceftriaxona 1 g/dia
Dispepsia funcional c/ plenitude	procinético: domperidona 10 mg 8/8 h ou metoclopramida 10 mg 8/8 h, 15–30 min antes das refeições, curto prazo

ABDOME AGUDO · VESÍCULA · PÂNCREAS

Quadro	Protocolo
Obstrução intestinal	jejum · **SNG aberta** · SF/Ringer + KCl conforme K · dipirona 1 g EV 6/6 h · ondansetrona 4–8 mg 8/8 h · sonda vesical · lactato/gaso · RX → TC · cirurgia se sofrimento ou falha em 48–72 h
Pancreatite aguda	monitorização · jejum inicial → VO em 24–72 h · **Ringer lactato** (metas) · dipirona 1 g 6/6 h ± morfina/tramadol · ondansetrona 4 mg 8/8 h · enoxaparina 40 mg SC · **sem ATB profilático** · UTI se grave · CPRE se colangite · colecistectomia na internação
Necrose infectada	**meropenem 1 g EV 8/8 h** (ou imipenem) + drenagem step-up
Colecistite	jejum, hidratação, analgesia · **ceftriaxona 1–2 g/dia + metronidazol 500 mg 8/8 h** · colecistectomia VLP precoce (≤ 72 h) · grave/alto risco: colecistostomia
Colangite	ressuscitação · ceftriaxona + metronidazol (grave: **pip-tazo 4,5 g 6/6 h** ou meropenem) · **drenagem por CPRE** (urgente no grau III) · colecistectomia depois
Apendicite	apendicectomia VLP + cefazolina 2 g (ou ceftriaxona + metronidazol); complicada: ATB 4–7 d
Diverticulite não complicada	dieta líquida, analgesia · amoxi-clav 875/125 12/12 h ou cipro 500 12/12 + metronidazol 500 8/8 h, 7–10 d · colonoscopia em 6–8 sem
Isquemia mesentérica	angio-TC · **heparina não fracionada plena** · ATB · revascularização · laparotomia se peritonite

DIARREIA · HIDRATAÇÃO · PARASITOSES

Quadro	Protocolo
Plano A	SRO após cada evacuação: < 1 a 50–100 mL · 1–10 a 100–200 mL · > 10 a à vontade · zinco 10 mg (< 6 m) / 20 mg (≥ 6 m) 10–14 d · alimentação habitual · sinais de retorno
Plano B	SRO 50–100 mL/kg em 4–6 h na unidade · vômitos: gastróclise 20–30 mL/kg/h · reavaliar
Plano C	SF 0,9%/Ringer · **cartaz 2023**: < 1 a 30 mL/kg em 1 h + 70 mL/kg em 5 h · ≥ 1 a 30 mL/kg em 30 min + 70 mL/kg em 2h30 · **cartaz antigo (APF T12)**: < 5 a 20 mL/kg em 30 min, repetir · SRO 5 mL/kg/h quando beber
Disenteria grave (criança)	**azitromicina** 10 mg/kg D1 + 5 mg/kg/d D2–5 (2023) · ou ciprofloxacino 15 mg/kg 12/12 h 3 d (antigo) · ceftriaxona 50–100 mg/kg/d se internada · **sem loperamida**
Oxiúro / Ascaris / ancilóstomo	albendazol 400 mg DU (oxiúro: repetir em 2 sem + família) · mebendazol 100 mg 12/12 h 3 d
Strongyloides	ivermectina 200 µg/kg DU (1–2 d) · albendazol 400 mg 3 d
Giardia	metronidazol 250 mg 8/8 h 5–7 d (criança 15 mg/kg/d) · secnidazol/tinidazol 2 g DU
Amebíase invasiva	metronidazol 500–750 mg 8/8 h 7–10 d + amebicida luminal (teclozana)
Teníase	praziquantel 5–10 mg/kg DU · albendazol 400 mg 3 d
Celíaca	dieta isenta de glúten para sempre + ferro/folato/vitaminas/cálcio

EXAMES: INDICAÇÃO E COMO SÃO FEITOS

Exame	Como é feito	Quando pedir
RX de abdome agudo	tórax PA em pé + abdome em pé + deitado	exame INICIAL: pneumoperitônio, obstrução (escada), volvo
USG de abdome	transdutor, sem radiação, jejum 6–8 h para vesícula	vesícula/colecistite (escolha), vias biliares dilatadas, criança/gestante, FAST no trauma/hemorrágico
TC com contraste	contraste IV (± oral); cuidado com função renal	diverticulite, obstrução (ponto de transição), complicações; pancreatite só se dúvida/> 72 h
Angio-TC	contraste IV em fase arterial	isquemia mesentérica
Colangio-RM	RM sem contraste iodado, não invasiva	coledocolitíase de risco intermediário, anatomia biliar, pancreatite crônica
Ecoendoscopia	endoscópio com transdutor no duodeno (sedação)	microcálculos/coledocolitíase intermediária, pancreatite crônica duvidosa, tumores
CPRE	duodenoscópio + cateter na papila + contraste; papilotomia	TERAPÊUTICA: coledocolitíase de alto risco, colangite (drenagem). Risco: pancreatite pós-CPRE
Cintilografia (HIDA)	radiofármaco excretado na bile; vesícula não enche = cístico obstruído	colecistite com USG duvidoso
EDA	endoscópio pela boca, sedação, jejum; biópsias (Hp: antro + corpo)	dispepsia com alarme/idade, HDA (≤ 24 h), úlcera gástrica (controle), celíaca (biópsia duodenal), DRGE refratária
pHmetria 24 h	cateter nasal até 5 cm acima do EEI (ou cápsula); **IBP suspenso ~7 dias**	provar DRGE: refratário, atípico, antes de cirurgia (padrão-ouro)
pH-impedanciometria	cateter com sensores de impedância + pH	refluxo ácido e NÃO ácido; sintomas em uso de IBP
Manometria esofágica	cateter de pressão; paciente engole água	antes da fundoplicatura (afastar acalasia/hipomotilidade); NÃO diagnostica DRGE
Teste respiratório da ureia	bebe ureia com ^{13}C; urease do Hp libera CO_2 marcado no ar	diagnóstico e CONTROLE DE CURA do Hp (≥ 4 sem pós-ATB, 2 sem sem IBP)
Antígeno fecal	amostra de fezes (monoclonal)	diagnóstico e controle de cura do Hp; bom em criança
Teste da urease (biópsia)	fragmento na EDA em meio com ureia; muda de cor	Hp em quem já está fazendo EDA
Sorologia Hp	IgG no sangue	só contato prévio; **nunca** controle de cura
Anti-tTG IgA + IgA total	sangue, **com glúten** na dieta	rastreio de doença celíaca → confirmar com biópsia duodenal
Teste do H_2 expirado	ingere lactose; mede H_2 no ar	intolerância à lactose
Fita adesiva (Graham)	fita na região perianal pela manhã, antes do banho	enterobíase
Elastase fecal	amostra de fezes	insuficiência pancreática exócrina (pancreatite crônica)

COMO ESCREVER A DISCURSIVA

- Uma discursiva por SP, sempre um caso com itens a–e. Os temas se repetem: **SP1 obstrução intestinal** (3/3) · **SP2 celíaca** (2/3) ou parasitose · **SP3 icterícia/coledocolitíase/pancreatite biliar** (3/3) · **SP4 HDA** (2/3) ou úlcera + H. pylori.
- Responda **exatamente o que o item lista**: se pede “regime, exames e tratamento”, escreva os três. “Síndrome” é síndrome (obstrutiva, colestática), não a doença.
- Diagnóstico sempre com **justificativa** (achados do caso). Conduta com **local** (UBS/enfermaria/UTI), **prescrição com droga + dose + via + intervalo + duração** e o **procedimento definitivo** com o momento (CPRE, colecistectomia na mesma internação, EDA em 24 h).
- “Cite 5” → escreva 5–6 (a correção é por item). Complicações: separe locais × sistêmicas quando pedir.

- Erros que já custaram ponto: colangite → colecistectomia · enfermaria com Ranson 4 · complicação de pancreatite crônica na aguda · “albendazol 14 dias” · EDA sem a finalidade terapêutica · “Mirizzi” quando pedia síndrome · simeticona na obstrução · USG “vendo” bridas.